جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مني خلف علي سجره
المحافظة : البحيره **الحي / المدينة :** وادي النطرون **العنوان :** ==
رقم البطاقة : 28610212601843 **رقم التليفون :** 01102322920 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 14-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 21-10-1986 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منى خلف على سجره
National ID: 28610212601843

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية

منى
خلف على سجره
امام مسعد الرحمن بن ابراهيم محمود
مركز وادى النطرون - البحيرة

٢٨٦ ١٠ ٢١ ٢٦ ٠١٨ ٤٣

KH2686681





مجلس مدينة وادى النطرون

الاثر مسلمة متزوجة
احمد خلف عبدالعال ظهر
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١٢/٣٤



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	**: منى خلف علي شجره**	**Patient Id**	**: 14338**
Patient Info.	**: Female 40Y**	**VisitId**	**: 338976**
Department	**: Out Patient**	**Collection Date**	**: 28/06/2026 11:49:03**
Profile NO.	**: 738-2022 / 7133**	**Reporting Date**	**: 28/06/2026 12:00:06**

COMPLETE BLOOD PICTURE

Test		Result	Unit	Reference Range
CBC				
Hemoglobin (HB)	:	13.0	g/dL	12 - 16
RBCs	:	4.38	10^6/cmm	3.8 - 4.8
Haematocrit (HCT)	:	39.6	%	36 - 46
MCV	:	90.4	fl	76 - 95
MCH	:	29.7	pg	26 - 32
MCHC	:	32.8	g/dL	32 - 36
RDW	:	12.40	%	11.6 - 14.5
Platelet count	:	H 715	10^3/cmm	150 - 450
WBCs	:	7.34	10^3/cmm	4 - 10

Differential white cell Count	*Relative*		*Absolute*	
	Relative (%)	*R.Range*	*Absolute (x 10^3/ul)*	*R.Range*
Neutrophils	59.70	40 - 70	4.38	2 - 7
Lymphocytes	29.20	20 - 45	2.14	1 - 3
Monocytes	H 8.50	2 - 8	0.62	Up To 1.o
Eosinophils	2.40	1 - 6	0.18	0 - 0.5
Basophils	0.20	0 - 1	0.01	0 - 0.1

Signature

Dr. Hassan Sayed Ahmed

[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

Name: مني خلف علي سجره	
MR. : 7133	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented to the clinic today for continuation of aromatase inhibitor therapy with Femara and supportive treatment with Zoladex for a planned three-month course, with a routine annual evaluation scheduled thereafter.

The patient is a 39-year-old female, pre-menopausal, who underwent right breast radiation therapy in March 2022 for multicentric malignant masses with ipsilateral lymphadenopathy (BIRADS 6, T3N1). Tumor immunohistochemistry was ER 8/8, PR 4/8, HER2 3+. She received TCHP chemotherapy, followed by post-radiation modified radical mastectomy with clear margins (YPTIB YPNO) and an IDC GII node-free specimen. In view of a partial pathologic response, she was started on adjuvant Kadcyla 3.6 mg/kg for 14 cycles, followed by adjuvant hormone therapy with an aromatase inhibitor and Zoladex.

Adjuvant therapy was continued with Femara 2.5 mg plus Zoladex today, with the next clinic visit scheduled for 16 August 2026.

The patient's breast cancer treatment history includes pre-operative TCHP, right breast radiation, modified radical mastectomy, 14 cycles of Kadcyla, and ongoing adjuvant aromatase inhibitor plus Zoladex therapy. She has also developed essential thrombocytosis, for which she is receiving hydroxyurea 500 mg every 8 hours; a laboratory work-up is planned for the following month.

The patient is currently on hydroxyurea 500 mg q8h for essential thrombocytosis, with labs scheduled for the next month.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Reham Ahmed Fathy Ibrahim**

يعتمد ,

Ministry of health & population
Secretarial of specialized medical centers
Dar Al salam cancer hospital
clinical pathology Lab.

مستشفى اورام دار السلام

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة معمل التحاليل

Patient Name	: الأستاذه / منى خلف على	Request No.	: 13002534
Patient No.	: 738-2022	Request Date	: 06/05/2025
Path No.	:	Verification Date	: 08/05/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 38 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ahmed Magdy

Bone Marrow Report

Differential count :

Normoblast	:	15
Blast	:	1
Promyelocyte	:	8
Meylocyte	:	7
Juvenile	:	6
Staff	:	12
Segmented	:	18
Lymphocytes	:	30
Monocytes	:	-
Eosinophils	:	-
Basophils	:	-
Plasma Cells	:	3

Comment:
Normocellular marrow
Normal erythropoiesis in count & morphology
Normal granulopoiesis in count with dysplasia
Normal megs in count with abundant cytoplasm
Partial dilution can not be excuded
Conclusion:
Normocellular marrow , case morphologically highly suggestive of ET for BMB& JAK II

DR. Naglaa Mostafa
Prof. of Hematopathology
Dr.Hend abd elhady
Assistant Professor of Hematopathology
National Cancer Institute
Cairo University

Verified by :
Dr.Asmaa Hamed

فاكس / 25311121 ت/ 25311125 - 25311128 987 كورنيش النيل الملك الصالح

Patient Name	: الأستاذه / مني خلف علي	Request No.	: 13002554
Patient No.	: 28610212601843	Request Date	: 06/05/2025
Path No.	: 1627/25	Verification Date	: 25/05/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Suspected ET.
Nature of the specimen: BMB
Gross Examination:
Two hemorrhagic bony cores, longest measured 1 cm long. Totally submitted.
Microscopic examination:
- Adequate: Yes
- Cellularity: Normocellular.
- Myeloid/erythroid ratio: Mild decrease
- Atypical cells infiltration: No
- Additional pathologic findings:

CD15: Highlight myeloid series.
CD61: Inreased Megakaryoytes with dysplastic forms.
Glyophorin: Increased granuloytic series.

Diagnosis:
BMB; Hypercellular marrow, Compatible with Essential thromboytosis.
Case for correlation with aspirate results and cytogenetic studies (JAK2).

Dr. Marwa Mahmoud
Dr. Heba Hassan

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patien; Name	: الأستاذه / مني خلف علي	Request No.	: 13000233
Patient No.	: 28610212601843	Request Date	: 22/01/2022
Path No.	: 196/2022	Verification Date	: 07/02/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 36 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Rt breast mass
Nature of the specimen:
Tru cut biopsy

Gross Examination:
- Procedure: tru cut
- Localization: Rt
- Tumor extent
  - Number: multiple gray white tissue cores up to 1.5cm, totally submitted.
  - Size: N/A
  - Skin involvement:N/A
- Distance from margins:N/A
- Lymph nodes number and size:N/A
- Additional pathologic findings:N/A
- Immunohistochemistry technique:Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)
- Frozen section:N/A

Microscopic examination:
- Histological type: IDC
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II (2+2+2)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: no
- Tumor extent
  - Number:N/A

Verified by :
Rana fathy

Room No. (4) - First Floor Building No. 287- Nile Corniche - Nile El Qobari - Cairo, Egypt

Patient Name	الأستاذه / مني خلف علي	Request No.	13000233
Patient No.	28610212601843	Request Date	22/01/2022
Path No.	196/2022	Verification Date	07/02/2022
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - مبادره
Age	36 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed y

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

o Size:N/A
o Skin involvement:N/A
• Lymph node involvement:N/A
• Resection Margins:N/A
o Free /DCIS/ invasive carcinoma
• Histologic response to therapy:N/A
• Additional pathologic findings:N/A

Diagnosis:
Rt breast mass, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma GIII.
Biomarkers:
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: weak nuclear reaction in 35% of tumor cells (Allred score 4/8)
Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)
Ki 67: 70 % nuclear reaction

Prof. Gamal Abdelaty
Dr. Rana Fathy

Verified by :
Rana fathy

Room No. (4) - First Floor - Building No. 887 - Nile Corniche - Nile El Qobbah - Cairo, Egypt

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECION SUPPORT

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الاصدار :2023-2-7 جهه الاصدار :رئاسة الهيئة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) منى خلف على بطاقة رقم 28610212601843

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية بفرد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنة مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2023-2-7

الموظف المختص

nelly karm

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 414847

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Mona Khalaf Ali Sgrh	Date : 16/07/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 738/2022	Pat. ID: 15102

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Right malignant breast masses, on neoadjuvant chemotherapy, coming for follow up

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO views DBT (Digital Breast Tomosynthesis).
- Bilateral breast ultrasound
- Comparison with previous mammography done in 1/2022

Report:

- The breasts are extremely dense which lowers the sensitivity of mammography (ACR D).
- No left suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound showed no left solid or cystic mass lesions.
- Right three ill-defined hypoechoic solid lesions seen at:

1. 10:00 measuring 0.7x0.5 cm (previous 2x2 cm)
2. 8:00 measuring 1.5x0.7 cm (previous 1.6x1.8 cm)
3. Retroareolar measuring 1.1x0.8 cm

- Bilateral retroareolar dilated ducts reaching 0.3 cm
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Left Nonspecific axillary LNs.
- Right two prominent axillary lymph nodes showing diffuse cortical thickening reaching 0.33 cm and preserved hilum

Opinion:

- Right partial response of malignant lesions and ipsilateral axillary lymph nodes as described above (BIRADS6)
- Bilateral duct ectasia (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

16/07/2022 1:30 PM

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Mona Khalaf Ali Sgrh	Date : 01/03/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 36 Year(s)
Medical ID:	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Compared to previous study dated 28.2.2022 the current study shows:

I Chest:-

- Right MRM with no operative bed mass lesions.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. The previosuly mentioned right hepatic lobe segment VII focal lesion is indistinct in the current study.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Left iliac bone tiny sclerotic foci, bone islands.

Reda MOustafa

NASSER INSTITUTE

ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT

معهد ناصر

مركز الأورام

وحدة الطب النووي

Patient Name: Mona Khalaf Ali. Date: 16/3/2022

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes are noticed over dorsal and lumbar vertebrae.
- Arthritic changes at knees and shoulders.
- No serious bone lesion detected.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

No define evidence of metastatic osseous deposits.
Follow up bone scan is advised..

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Sherien Mahdy,MD

Huda Fathy,M.D

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

Sex: Female

3- Medical number: 83061172

Patient Age : 36 Y

MDT

Phone 01273868758

over weight (26)

NRS Score (2)

marital status MARRIED

Co morbidity

29-Sep-2022

REASON OF MDT POST OPERATIVE

Clinical data

Mets Workup :
BONE SCAN FREE 3/2022

	IHC:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	KI67 :
3/2022		8/8	4/8	+VE	70%

	N	M
	1	0

mammography

LT BREAST MULTICENTERIC MALIGNANT MASSES WITH IPSILATERAL
ADENOPATHY BIRADS 6

Operations:

- LT MRM - IDC GII
- LT FREE - NODE FREE
- PBHO
- MED PCHP

MDT OUTCOME & PLAN

- of partial pathologic response
- 3.6mg /kg for 16 cycles
- HT AI+ ZOLADEx

SIGNATURE

ONCOLOGY	د/ ايمن عبدالحميد	RADIOLOGY	د/ هالة نور
		PATHOLOGY	
ric		Nutrition	